

01 - 01- Pleurésies - Pr. Bouchentouf

(0:01 - 1:19)

Bonjour, chers étudiants, le cours d'aujourd'hui, c'est les pleurises. Les objectifs pédagogiques sont au début définir une pleurise, décrire les mécanismes de constitution d'une pleurise, savoir différencier entre un épanchement pleural exudatif et transudatif, réunir les arguments du diagnostic positif et différentiel d'une pleurise, énumérer les principales étiologies d'une pleurise selon l'aspect du liquide, réunir les arguments du diagnostic étiologique d'une pleurise sérophibineuse, hémorragique, périlante, échineuse, identifier les principes du traitement d'une pleurise. Le plan du cours comporte en première définition, en deuxième, la physiopathologie, c'est-à-dire comment la construction de l'épanchement pleural, le diagnostic positif de l'épanchement pleural liquidien, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique, le traitement avant de conclure.

(1:26 - 1:51)

En définition, l'épanchement pleural, ou la pleurise, c'est la présence d'une quantité anormale de liquide dans la cavité pleurale, qui résulte d'un déséquilibre entre la formation et l'évacuation du liquide pleural. C'est un syndrome fréquent. Les causes sont multiples, mais elles sont dominées par les infections, en particulier la tuberculose, les néoplasies, les cardiopathies.

(1:51 - 2:18)

Pour le traitement, elle comporte trois volets, l'évacuation de l'épanchement, une kinésithérapeute respiratoire, sans oublier le traitement étiologique. Un rappel physiopathologique, la pleure est une cavité virtuelle, où règne une pression négative. Une faible quantité anormale est produite en 5 à 20 cc par la pleure paritale et réservée par les circuits lymphatiques.

(2:19 - 2:55)

Le liquide pleural permet aux feuilles paritales et viscérales de glisser l'un contre l'autre au cours des cycles respiratoires. L'épanchement pleural est la conséquence d'un déséquilibre entre la production du liquide et sa résorption. À retenir, lorsque la pleure est pathologique, il s'agit d'un exudat.

(2:55 - 3:28)

Un transudat résulte d'un déséquilibre mécanique entre les pressions hydrostatiques et oncotiques vasculaires. La pleure, dans ce cas, est normale. En ce qui concerne le diagnostic positif, on prend comme type de description un épanchement pleural de moyenne abondance.

(3:29 - 4:21)

Les signes cliniques et les séquences de découverte sont soit des signes fonctionnels, il s'agit de douleurs thoraciques, ou de toux sèche ou disciplinée, en fonction de l'importance de l'épanchement, soit à l'occasion de manifestations trompeuses, par exemple, soit une découverte fortuite, une découverte radiologique pour une pathologie X. L'examen clinique, c'est l'examen respiratoire à l'horachage qu'on appelle, sur le plan sémiologique, le syndrome pleural. À la palpation, on a une diminution ou abolition des vibrations vocales. À la percussion, une matité franche.

(4:21 - 4:48)

Et à l'auscultation, une diminution ou abolition des murmures vésiculaires. On peut également, c'est moins fréquent de voir, des frottements pleurales ou des souffles pleuraux. L'examen général, on recherchera systématiquement une fièvre, une altération de l'état général, sans oublier l'examen des aires ganglionnaires.

(4:48 - 5:20)

L'examen complémentaire important, c'est la radiographie thoracique. C'est un élément d'orientation. Il affirme le diagnostic en montrant une opacité de tonalité hydrique, basithoracique, concave en haut et en dedans, qui efface la coupole diaphragmatique.

(5:21 - 7:16)

La radiographie thoracique permet également d'évaluer l'abondance de l'épanchement, soit de faible, de moyenne ou de grande abondance, chercher des signes de compression, c'est-à-dire refoulement du médiastin, du contrôle latéral ou de la trachée, et rechercher s'il y a d'anomalies thoraciques associées qui vont orienter vers telle ou telle pathologie. La tomodensitométrie thoracique n'est pas systématique, mais lorsqu'elle est indiquée, elle peut montrer une opacité homogène d'équilibre bien visible sur les fenêtres médiastinales et permet également de distinguer un processus expansif pleuroparital d'un abcès pulmonaire, rechercher également des anomalies thoraciques associées et repérer s'il y a une pleurysie cloisonnée ou la panxionnée. L'échographie thoracique, c'est un examen peu invasif qui utilise du ultrasound, permet de confirmer l'origine liquidienne de l'opacité, aspect anécogène, c'est-à-dire liquidien, diagnostiquer une pleurysie ankystée, différencier entre un épanchement liquidien et un épanchement pleural, permettre également de distinguer entre une atélectasie et un épanchement pleural.

(7:17 - 7:56)

L'échographie est utile si on a suspicion de kysthytatie et permet également de guider la panxion. La panxion pleurale, c'est l'examen qui confirme le diagnostic de pleurysie. Tout d'abord, il faut mettre en condition votre patient, contrôler le bilan des moustaches, le patient assis au bord du lit, tête rentrante, une asepsie rigoureuse et repérer le site de panxion.

(7:59 - 8:44)

Le siège de la ponction au niveau de l'espace intercostal, il faut raser le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le pas qui va à l'armoire, éviter les hémorragies, éviter les douleurs. L'analyse, on l'analyse macroscopique, l'aspect macroscopique du liquide pleural, la biochimie, c'est avec l'étude du taux de protéines autour du LDH, la cytologie, la numération formule cellulaire, également rechercher des sites mycoplasmes, sans oublier un prélèvement microbiologique à la recherche de germes bactériens et de champignons. Après la ponction, il ne faut pas oublier de faire une radiographie thoracique de contrôle.

(8:46 - 9:53)

Donc la ponction, elle permet, elle est systématique, elle permet de confirmer le diagnostic des épanchements pleuraux et liquidiens. Cependant, la ponction pleurale peut attendre, en cas d'épanchement de faible abondance et en cas d'insuffisance cardiaque gauche, la ponction pleurale, son intérêt, il permet de confirmer le diagnostic, il permet une étude macroscopique du liquide pleural, assurer des prélèvements du liquide pour l'analyse, on a la chimie, la cytose et la bactérie, et permet une orientation diagnostique et thérapeutique, comme on dit, la ponction pleurale est systématique pour confirmer le diagnostic d'un épanchement pleural liquidien. Cependant, il faut faire attention, il y a des contre-indications en cas de trouble de la coagulation, en cas de kystique.

(9:54 - 10:30)

Ces complications, c'est le saignement et l'infection, également le pneumothorax, d'où l'intérêt d'une radiographie thoracique de contrôle après une ponction pleurale. Voyons maintenant les différents aspects du liquide pleural. L'aspect macroscopique le plus fréquent, c'est du liquide jaune citrin, séro-fibrineux, le deuxième, c'est le séro-hématique, puis on aura le pur et le lactescent ou le chyleux.

(10:35 - 11:03)

Pour différencier entre un exsudat et un transsudat, on se base en premier lieu sur le taux de protéines. S'il est inférieur à 25 g par litre, c'est un transsudat. S'il est supérieur à 35 g par litre, c'est un exsudat.

(11:04 - 11:51)

Mais entre 25 et 35, on ne peut pas trancher, donc on va s'aider par utiliser les critères de Leitz, c'est-à-dire on va doser le LDH, s'il est supérieur à 200 unités internationales par litre, c'est un exsudat, ou faire le rapport des protéines plasmiques sur les protéines sériques supérieures à 0,5 ou les LDH sur les LDH sériques supérieures à 0,6. La présence d'un de ces critères classe dans le chapitre des exsudats. La différence entre un transsudat et un exsudat, le transsudat est un liquide

pauvre en protéines, alors que l'exuda est un liquide riche en protéines.

(11:52 - 12:14)

La plèvre, dont les épanchements transudatifs sont saines, alors qu'elle est malade, donc a d'exudas. Le traitement de la maladie dans le transuda, de la maladie causale, entraîne généralement la régression de l'épanchement. La biopsie plurale.

(12:15 - 12:40)

On doit avoir une orientation étiologique. On a dit que les étiologies les plus fréquentes sont infectieuses, c'est-à-dire les néoplasies qui ont des défauts cardiaques. La biopsie plurale, sans indication, devant tout exuda, sans confirmation diagnostique, permet une analyse histologique et apporte le diagnostic de certitude en cas de tuberculose ou de néoplasie.

(12:41 - 13:01)

La méthode se fait soit par une pension biopsie plurale percutanée à la veuve ou par thoracoscopie. Dans la pension biopsie plurale à la veuve, c'est dans le cas de tuberculose parce que les lésions sont diffuses et le rendement est le plus important. Mais en cas de néoplasie, c'est l'intérêt de la thoracoscopie.

(13:05 - 13:26)

Vous voyez la biopsie plurale. Elle est indiquée en pluralsie exudative, se fait en position assise, anesthésie locale, en courte incision bistouri, introduction de l'aiguille d'Abrams, issue du liquide goutte à goutte. Pour faire des biopsies, on fait des évacuations de l'épanchement et un contrôle complété par un contrôle clinique et radiologique.

(13:28 - 13:37)

Maintenant, les formes cliniques. Les formes en fonction de la nature du liquide. Selon les formes, l'aspect macroscopique.

(13:38 - 13:50)

On a des pluralsies à liquide clair qui sont généralement transidatives. Les pluralsies sérophibineuses, la couleur c'est jancitrin. Les pluralsies séro-hématiques.

(13:50 - 13:58)

Les pluralsies périlentes. Et les pluralsies chuleuses. Egalement, ce sont les résultats du laboratoire.

(13:58 - 14:19)

En particulier le taux de produits. On peut parler de pluralsies transidatives et de pluralsies exudatives. Également, selon l'abondance de l'épanchement, on peut parler de pluralsies minimales avec émoussement du cul de sac pleural, costale diaphragmatique.

(14:20 - 14:34)

Le signifiant le plus important, c'est la douleur baso-thoracique. Les pluralsies également de faible abondance. Opacité basale gauche d'allure pleurale, avec une quantité qui est inférieure à 500 millilitres.

(14:34 - 14:58)

Également, la pluralisie abondante avec un aspect demi-thorax gauche opaque, refoulant les éléments d'humidité et l'incendie. Ici, le plus fréquent, c'est que le malade se plaint de dyspnée. Également, selon les formes topographiques, on peut avoir des pluralsies bilatérales, qui sont soit d'emblée, soit avec l'évolution.

(14:59 - 15:23)

Les pluralsies bilatérales, il faut évoquer souvent une cardiopathie ou une maladie de système connectée avec le lupus. Également, on peut avoir des pluralsies localisées ou conquises. Ce sont les pluralsies apicales, au niveau de l'apex, axillaires, interlobaires ou intracavités, notamment chez les cardiaques, ou sous-pulmonaires, c'est-à-dire diaphragmatiques.

(15:26 - 16:02)

Et selon l'association à d'autres atteintes, à d'autres séreuses, le péricard, péricardite avec épanchement, méningite, atteinte des péricardites, ainsi qu'une atteinte des autres séreuses, notamment d'une polysérite. Également, on peut associer l'épanchement plural à une atteinte thoracique, qui peut être pulmonaire, le cas de tuberculose ou cancer bronchique, médiastinal, le cas d'allélopneumonie, médiastinal ou tumeur médiastinale. Également, peut-être associé à un épanchement aérien, qu'on appelle maintenant épanchement mixte, un hydropneumothorax.

(16:06 - 16:39)

Pour ce qui concerne le diagnostic différentiel, le diagnostic différentiel se pose avant la radiographie et à la radiographie. Donc, la radiographie à l'examen clinique, pour éliminer un cas sténosant pulmonaire énorme, une atelectasie, un épanchement péricardique abondant, ou un paquet plurilobé étendu. À la radio, surtout le cas sténosant pulmonaire énorme, l'atelectasie, la pneumonie massive, une énorme tumeur pulmonaire, la pneumotomie et l'hernie diaphragmatique.

(16:42 - 17:41)

Ce qui est important dans l'épanchement plural, parce que, franchement, la pleurisie est un syndrome fréquent, c'est surtout chercher l'étiologie. Et la pleurisie pose un problème de diagnostic étatique. Et l'enquête étiologique va comporter un interrogatoire minutieux, rechercher les signes généraux particuliers, la fièvre et l'altération de l'état général, l'examen clinique de l'appareil respiratoire et l'examen général, la radiographie thoracique, les liquides de ponction plurale, son aspect, sa chimie, cito et bactéro, les issues histologiques et les autres examens, en fonction de l'orientation diagnostique, une numération formée sanguine, un énoGramme sanguin, une protidémie, une fonction rénale, un bilan inflammatoire, un bilan immunologique, une intra-dermo-réaction à la tuberculine, une broncoscopie.

(17:45 - 18:14)

Maintenant, selon l'aspect macroscopique, le cas du sérophibre bruneux le plus fréquent, les étiologies les plus fréquentes, la tuberculose. En deuxième, les causes malignes, les métastases, les hémopathies malignes, le mésotélium, c'est une tumeur pleurale primitive, après les autres. En cas de séro-hématique, il faut penser en premier lieu aux causes malignes, les métastases, le mésotélium et les hémopathies.

(18:15 - 18:31)

En deuxième, les causes cardio-vasculaires, en troisième, la tuberculose. Le cas du pyogène, la pleurysie pyrulente, les germes pyogènes, le pneumococque, le streptococque. Également, il faut penser à la tuberculose, aux parasites.

(18:31 - 19:13)

Vous voyez, la tuberculose, c'est l'étiologie, on le trouve en cas de pleurysie sérophibre bruneuse, en cas de pleurysie séro-hématique, en cas de pleurysie pyrulente. En fonction de l'analyse biochimique, on peut différencier un oxidaire et un transidaire, on peut être orienté vers l'étiologie. L'acétologie pleurale, également une pathologie à prédominance inflammatoire, également comme la tuberculose, la prédominance de polynucléotides, neutrophiles, en cas de pleurysie pyrulente à germes banales, les pleurysies éosinophiles, en cas de pleurysie médicamenteuse.

(19:13 - 19:48)

Également, on peut rechercher les cellules tumorales. L'analyse bactériologique se fait à l'examen direct de la culture, pour les germes pyogènes et pour les mycobactéries. Également, il y a d'autres, le pH pleural en cas de pleurysie pyrulente, l'hématocrite pleural en cas de suspicion d'un motax, l'amylase pleurale en cas de suspicion d'une pancréatite, les triglycérides en cas de suspicion d'une pleurysie chéuse, et le glucose intrapleural, également pleurysie pyrulente, ou la pleurysie associée au connectivite.

(19:53 - 20:27)

Donc, c'est ce qu'ont les étiologies. Le cas de pleurysie, c'est la fibulose, c'est-à-dire la tuberculose, les causes malignes, et les autres causes qui peuvent être infectieuses, bactériennes ou virales, cardiovasculaires, les collagenoses dans le cas de polyarthrité matose de l'hépice, ou iatrogène, peut-être, en cas de pleurysie d'origine médicamenteuse. Les pleurysies hémorragiques, ce sont des épanchements pleuraux avec un liquide rosé, séro-hématique ou franchement sanglant, mais incoagulable.

(20:27 - 20:51)

La pension pleurale permet de confirmer le diagnostic. Et les étiologies les plus fréquentes, ce sont, on m'a dit, les causes malignes, puis cardiovasculaires, en particulier les patients sous traitement anticoagulant, et, en troisième, la tuberculose. Le chapitre très important, les pleurysies pyrulentes, ce sont les moins fréquentes, mais les plus graves.

(20:52 - 21:12)

Le pronostic, il est simple, s'il n'y a pas un diagnostic précoce, un traitement adapté. Donc, définissant les pleurysies pyrulentes, c'est un épanchement pleural, franchement pyrulent ou simplement louche, mais avec des polynucléaires atterrés. Dans 70%, cette pleurysie est d'origine primitive.

(21:13 - 21:31)

La pleurysie, il faut savoir, pyrulente, évolue en stades. Il y a le premier stade de diffusion, un stade de collection, et un stade d'enquête. Le stade de diffusion, ce stade au début.

(21:32 - 21:55)

Le tableau est celui d'une pleuropathie aiguë qui ne s'améliore pas sous traitement antibiotique. L'examen physique retrouve un syndrome d'épanchement liquidien, et la radiographie thoracique montre la présence d'opacités floues de la base qui sont peu évocatrices. La phase d'état, c'est le stade de collection.

(21:55 - 22:10)

On aura un syndrome d'épanchement liquidien à l'examen physique. Le plus important, c'est un état général atterré. Et la radiographie thoracique va montrer une opacité dense, concave, en rayons de dents.

(22:10 - 22:24)

Et c'est la ponction pleurale qui confirme le diagnostic. On fait des prélèvements à la recherche de

germes banals et de bécares. En cas d'infection par les anaérobies, on aura une odeur fétide.

(22:27 - 22:50)

Dans le stade de collection, on voit une opacité d'équilibre concave en haut et en dedans. Et c'est la ponction pleurale qui va remener du liquide purulent ou clair avec des pôles nucléaires alternés. Le stade d'enquistement, vous avez la plèvre qui est épicée.

(22:51 - 23:09)

Dans ce cas, le stade d'enquistement, les lésions sont irréversibles. D'où l'intérêt d'agir préconçument, de ne pas arriver à ce stade. Donc, tout épanchement pleural fibril doit être ponctionné.

(23:10 - 23:21)

C'est notre message. Tout épanchement pleural fibril doit être ponctionné. Et la pleurésie purulente, c'est une urgence thérapeutique.

(23:21 - 23:35)

La pleurésie purulente est une urgence thérapeutique. Les étiologies de pleurésie purulente sont souvent banales. Sans oublier la tuberculose.

(23:36 - 24:02)

Et en cas de pleurésie purulente bactérienne, il faut penser à une pleurésie purulente décapitée par une antibiothérapie pré-arabe. Il faut penser également à une pleurésie tuberculeuse ou à une pleurésie amibienne. La pleurésie chéleuse, l'aspect macroscopique de la pleurésie chéleuse, c'est un liquide blanc et lactescent, c'est comme du lait.

(24:03 - 24:27)

Sur le plan biochimique, c'est un liquide riche en triglycérides et pauvre en cholestérol. Et les étiologies sont essentiellement le traumatisme du canal thoracique et les tumeurs médicinales, en particulier les hémopathies, les malaises, les lymphomes, Hodgkinien et non Hodgkinien. Le dernier chapitre des pleurésies, ce sont les pleurésies transsudatives.

(24:28 - 24:46)

Les étiologies sont l'insuffisance cardiaque. En cas d'insuffisance cardiaque, la pleurésie est souvent bilatérale. On voit une cardiomyopathie, un œdème pulmonaire, mais surtout l'amélioration sous-diurétique.

(24:47 - 24:58)

L'amélioration sous-diurétique. Également, on a un syndrome néphrotique. Le penchement pleural est bilatéral et symétrique.

(24:58 - 25:19)

Et à l'hôpital, on trouve une hypoprotidémie associée à une protéine urine. En cas d'insuffisance hépatocellulaire, le penchement est souvent droit, parfois bilatéral. Il faut rechercher les signes de cirrhose, notamment l'hépatomygalie, l'acide et la circulation veineuse qui est bilatérale.

(25:19 - 25:28)

Il y a d'autres. L'embolique pulmonaire peut donner des penchements transsudatifs et exudatifs. Il y a d'autres qui donnent des pleurésies transsudatives.

(25:29 - 25:40)

En cas de péricardie chronique consécutive et myxodé. Mais il faut reconnaître ces trois étiologies. Les étiologies des pleurésies transsudatives, il faut penser au cœur, au rein et au foie.

(25:41 - 26:11)

Les étiologies des pleurésies transsudatives, c'est l'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique et l'insuffisance hépatocellulaire ou également la cirrhose du foie. Le traitement. Le but du traitement des pleurésies, c'est soulager tout d'abord le patient, évacuer les penchements, tarissement rapide des penchements et restituer une restitution fonctionnelle aussi parfaite possible.

(26:11 - 26:39)

Le traitement symptomatique. Un traitement étiologique. Un traitement symptomatique comporte des ponctions évacuatrices, des drainages thoraciques, la synthèse pleura, c'est-à-dire faire instiller de la substance qui va irriter la plèvre, entraîner un accollement des feuilles pleurales, viscérales et parétales selon ce qu'on appelle le talquage.

(26:40 - 26:50)

La kinésithérapie respiratoire très importante en cas de penchement pleural. L'oxygénothérapie si besoin. Également sans oublier le traitement symptomatique de la douleur.

(26:52 - 27:01)

Et le traitement étiologique. En fonction de l'étiologie, si on a des tuberculoses, c'est des antituberculeux. Si on a des pleurésies pérennes, on a des antibiotiques.

(27:02 - 27:10)

Si on a un problème cardiaque, c'est les diurétiques. Également en cas de cirrhose, en cas d'atteinte rénale. Des digitales diurétiques en cas d'atteinte cardiaque.

(27:10 - 27:17)

La corticothérapie en cas de maladie de système. La chimiothérapie en cas de cancer. La chirurgie également.

(27:20 - 27:32)

En conclusion, la pleurésie est un syndrome fréquent. Le diagnostic est évoqué selon les données cliniques de l'imagerie thoracique. Il est confirmé par la ponction.

(27:33 - 27:44)

Toute pleurésie doit être ponctionnée, sauf si elle est minime. Dans l'étiologie, elle est connue. Devant toute pleurésie, il faut différencier entre un transsudat et un exsudat.

(27:45 - 28:07)

L'orientation étiologique dépendra de l'aspect microscopique et selon l'étude biologique de ce liquide. Toute pleurésie fébrile ou suspicion d'embolie doit être ponctionnée d'urgence. Tout exsudat qui n'a pas fait sa preuve doit bénéficier d'une indication d'une ponction biopsie pleurale.

(28:08 - 28:10)

Merci pour votre attention.